

CAPÍTULO 13.29

Diferencias entre EPOC y Asma

PERFIL EUNACOM 1.05.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La espirometría es la herramienta fundamental para el estudio de las enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas. Para el examen EUNACOM, la interpretación debe ser sistemática y rápida, centrándose en la relación VEF1/CVF, la CVF y la respuesta al broncodilatador (BD).

Algoritmo de Interpretación Rápida

Para analizar cualquier espirometría, siga estos tres pasos en orden:

- **Relación VEF1/CVF (Índice de Tiffeneau):**
- Si es < 70% (0.7): Existe un **Patrón Obstructivo**.
- Si es > 70% (0.7): No hay obstrucción. Pase al siguiente paso.
- **Capacidad Vital Forzada (CVF):**
- Si la relación es normal pero la CVF es < 80% del teórico: Sugiere un **Patrón Restrictivo**.
- Si tanto la relación como la CVF son normales: Espirometría **Normal**.
- **Prueba de Broncodilatador (BD):**
- * Se considera positiva si el VEF1 sube un 12% y 200 ml respecto al basal (en la práctica clínica rápida, un aumento del 15% es un indicador fuerte de reversibilidad).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología del Atrapamiento Aéreo: En casos de obstrucción muy severa, la CVF puede aparecer disminuida. Esto no siempre significa que haya restricción asociada, sino que el paciente retiene tanto aire (aumento del volumen residual) que la capacidad vital forzada disminuye mecánicamente.

3. El Patrón Restrictivo

En el **Caso 3**, la relación VEF1/CVF es del 80% (normal), lo que descarta obstrucción. Sin embargo, la CVF es del 53%. -

Interpretación: Cuando los pulmones son "pequeños" o rígidos, la cantidad total de aire que pueden expulsar es poca, pero lo hacen rápido (por eso la relación es normal). Esto es típico de la **Fibrosis Pulmonar** o enfermedades de la pared torácica.

4. Espirometría Normal

En el **Caso 4**, todos los parámetros están en rango: - Relación VEF1/CVF > 70%. - CVF > 80% del teórico. - VEF1 > 80% del teórico.

5. Obstrucción Severa

En el **Caso 5**, la relación es extremadamente baja (42%) y no responde al BD (sube a 44%). Esto indica una limitación crónica al flujo aéreo muy marcada, característica de pacientes con EPOC avanzado o tabaquismo de larga data.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Error común: No confundir el porcentaje de la relación VEF1/CVF con el porcentaje del teórico del VEF1. 1. La **Relación** (Tiffeneau) define SI HAY obstrucción (punto de corte 0.7). 2. El **VEF1 % teórico** define QUÉ TAN GRAVE es la obstrucción.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Si en una pregunta de EUNACOM te dan una espirometría con relación normal y CVF baja, el siguiente paso suele ser solicitar la medición de **Volúmenes Pulmonares** (Pletismografía) para confirmar la restricción mediante la Capacidad Pulmonar Total (TLC).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 55 años, fumador, llega a urgencia con disnea severa y sibilancias. Tiene antecedente de EPOC moderado. Saturación de 84%. ¿Cuál es la conducta correcta respecto al oxígeno?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Diferencias entre EPOC y Asma. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

Análisis de Casos Clínicos

A continuación, se presentan 5 ejercicios prácticos basados en la interpretación de valores basales y post-broncodilatador.

Tabla Comparativa de Ejercicios

TABLA 13.29.1: CASO VS VEF1/CVF BASAL				
CASO	VEF1/CVF BASAL	VEF1/CVF POST-BD	CVF (% TEÓRICO)	DIAGNÓSTICO SUGERIDO
1	62% (Bajo)	79% (Normal)	Normal	Asma
2	60% (Bajo)	62% (Bajo)	Normal	EPOC Moderado
3	80% (Normal)	80% (Normal)	53% (Bajo)	Patrón Restrictivo (Fibrosis Pulmonar)
4	75% (Normal)	78% (Normal)	85% (Normal)	Espirometría Normal
5	42% (Bajo)	44% (Bajo)	Normal/Bajo	Patrón Obstructivo Severo (EPOC)

Detalle de los Hallazgos

1. El Patrón Obstructivo Reversible (Asma)

En el **Caso 1**, partimos con una relación del 62%. Al aplicar el broncodilatador, esta sube a 79% (una mejoría absoluta de 17 puntos porcentuales). Este cambio es muy significativo. - **Clave:** Un patrón obstructivo que normaliza sus valores con BD es patognomónico de asma en el contexto de un examen.

2. El Patrón Obstructivo No Reversible (EPOC)

En el **Caso 2**, la relación basal es 60% y post-BD es 62%. La mejoría es mínima (2%). - **Clasificación de severidad:** Para graduar el EPOC, miramos el **VEF1 basal**. - Leve: > 80% - Moderado: 50 - 80% - Severo: 30 - 50% - Muy severo: < 30% - En este caso, con un VEF1 del 63%, se clasifica como **EPOC moderado**.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- En asma estable: corticoides inhalados van antes que broncodilatadores de acción larga. En EPOC: broncodilatadores de acción larga van antes que corticoides inhalados.
- En asma, todo el tratamiento aumenta la sobrevida. En EPOC, solo dejar de fumar y el oxígeno domiciliario aumentan la sobrevida.
- Crisis asmática: oxígeno sin restricción. EPOC descompensado: oxígeno al 24% con precaución por riesgo de hipercapnia.
- Crisis asmática: antibióticos solo si hay neumonía confirmada. EPOC descompensado: antibióticos casi siempre.
- Crisis asmática: la pregunta clave es si hospitalizar o no. EPOC descompensado: se hospitaliza siempre y la pregunta es si conectar a ventilación mecánica.
- La decisión de ventilación mecánica en EPOC descompensado se basa en los gases arteriales.
- En Chile, los pacientes con EPOC descompensado suelen hospitalizarse transitoriamente en salas ERA (Enfermedades Respiratorias del Adulto).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIFERENCIAS ENTRE EPOC Y ASMA)**PREGUNTA 1**

Paciente de 55 años, fumador, llega a urgencia con disnea severa y sibilancias. Tiene antecedente de EPOC moderado. Saturación de 84%. ¿Cuál es la conducta correcta respecto al oxígeno?

- A)** Administrar oxígeno al 100% por mascarilla de reservorio, igual que en una crisis asmática.
- B)** Administrar oxígeno al 24% y solicitar gases arteriales antes de modificar la FiO₂.
- C)** No administrar oxígeno hasta confirmar el diagnóstico con espirometría.
- D)** Administrar oxígeno por cánula nasal a 5 litros/minuto sin control gasométrico.
- E)** Administrar oxígeno al 50% ya que la saturación está muy baja.

PREGUNTA 2

¿Cuál de las siguientes diferencias entre el manejo crónico del asma y del EPOC es correcta?

- A)** En ambas patologías los corticoides inhalados son primera línea después de los broncodilatadores de acción corta.
- B)** En el asma los broncodilatadores de acción larga van antes que los corticoides inhalados.
- C)** En el EPOC los broncodilatadores de acción larga van antes que los corticoides inhalados, mientras que en el asma es al revés.
- D)** En el EPOC los corticoides inhalados aumentan la sobrevida al igual que en el asma.
- E)** En ambas patologías el tratamiento farmacológico inhalatorio aumenta la sobrevida.

PREGUNTA 3

Paciente de 60 años con antecedente de asma bronquial llega a urgencia con crisis asmática moderada. Radiografía de tórax sin infiltrados. ¿Cuál es la conducta respecto a los antibióticos?

- A)** Dejar antibióticos siempre, al igual que en el EPOC descompensado.
- B)** Dejar antibióticos profilácticos por 3 días.
- C)** No dejar antibióticos ya que no hay evidencia de neumonía en la radiografía.
- D)** Dejar antibióticos solo si hay leucocitosis.
- E)** Dejar antibióticos empíricos ante la duda diagnóstica.

RESUMEN: DIFERENCIAS ENTRE EPOC Y ASMA

Esta clase establece un paralelo clínico-terapéutico entre el asma y el EPOC, tanto en sus formas estables como descompensadas, con el objetivo de evitar las confusiones frecuentes entre ambas patologías. En el manejo estable, la diferencia clave es el orden terapéutico: en el asma los corticoides inhalados preceden a los broncodilatadores de acción larga, mientras que en el EPOC los broncodilatadores de acción larga van antes que los corticoides inhalados. Además, en el asma el tratamiento completo aumenta la sobrevida, mientras que en el EPOC solo dejar de fumar y el oxígeno domiciliario lo logran; los inhaladores solo son para alivio sintomático. En el escenario de urgencia, las diferencias son igualmente importantes. En la crisis asmática el oxígeno se administra sin restricción (no hay riesgo de hipercapnia), mientras que en el EPOC descompensado se da al 24% con precaución por el riesgo de retención de CO₂. Respecto a los antibióticos, en la crisis asmática solo se indican ante neumonía confirmada, mientras que en el EPOC descompensado se dejan casi siempre por la alta frecuencia de neumonías bacterianas que pueden no evidenciarse en la radiografía. Otra diferencia fundamental es la decisión clínica principal en urgencia: en la crisis asmática la pregunta es si se hospitaliza o no (se hospitaliza cuando el paciente está muy grave o no responde al tratamiento), mientras que en el EPOC descompensado habitualmente se hospitaliza siempre (al menos transitoriamente en salas ERA en el sistema público chileno) y la pregunta clave es si se conecta o no a ventilación mecánica, decisión que se toma en base a los gases arteriales.